

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15.

Медико-психологические аспекты помощи при нарушениях психики у пострадавших, медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях

Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций:{

=картина разрушений, аварий, паники, вид пораженных, человеческих жертв, потеря близких друзей

~нервно-психические расстройства, паники, вид пораженных, друзей, коллег

~природные, техногенные, социальные

~нервно-психические расстройства, аварий, потеря близких, друзей, коллег

}

Стадии развития чрезвычайных ситуаций:{

~стадии зарождения, инициирования, кульминации, взрыва и кульминации

~стадии неожиданности, воздействия неблагоприятных факторов ЧС, лечения, профилактики

~стадии воздействия неблагоприятных факторов ЧС, лечения, профилактики

=стадии зарождения, инициирования, кульминации, затухания

}

Динамика развития нервно-психических реакций при стихийных бедствиях:{

=фаза страха, гиперкинетическая и гипокINETическая фаза, фаза психических нарушений, фаза вегетативных изменений (фаза демобилизации/декомпенсации)

~фаза демобилизации, фаза декомпенсации, фаза психических нарушений

~депрессия, ипохондрия, тревожность, агрессивность

~фаза страха, гиперкинетическая и гипокINETическая фаза, фаза вегетативных изменений (фаза демобилизации/декомпенсации)

}

Фазы изменения функциональных резервов организма спасателей в процессе профессиональной деятельности:{

~фазы мобилизации, первичной реакции, гиперкомпенсации, компенсации, субкомпенсации, декомпенсации
~фазы мобилизации, первичной реакции, гиперкомпенсации
=фазы мобилизации, первичной реакции, гиперкомпенсации, компенсации, субкомпенсации, декомпенсации, срыва
~фазы мобилизации, компенсации, субкомпенсации, декомпенсации, срыва
}

В очаге бедствия преобладают нарушения психического состояния у пострадавших в виде: {

~ %25% снижения или утраты способности самостоятельно удовлетворять потребности в тепле, пище, безопасности
~ %25% высокой вероятности «эмоционального заражения» паническими, агрессивными, истерическими реакциями
~ %25% нарушения способности к планированию собственных действий
~ %-100%повышенной работоспособности
~ %25% значительного сужения временной перспективы
}

Особенности обращения (поведения) с пораженными, имеющими нарушения психической деятельности, возникшие в ЧС различного характера: {

~ %20% необходимо обеспечить безопасность для самого пораженного и окружающих его лиц
~ %20% ликвидировать обстановку растерянности, паники, нездорового любопытства
~ %20% отношение к пострадавшему должно быть заботливым, спокойным и в то же время решительным и твердым
~ %20% необходимо убрать от больного колющие, режущие предметы
~ %20% помнить основное правило психиатрического надзора – он должен быть тщательным, непрерывным и действенным
}

Какие критерии используются при проведении медицинской сортировки лицам с психическими расстройствами: {

~ %33.33333% состояние сознания (нарушения есть или нет)

~ %33.33333% наличие двигательных расстройств (психомоторное возбуждение или ступор)

~ %33.33333% особенности эмоционального состояния (возбуждение, депрессия, страх, тревога)

~ %-100%особенности общения пострадавших со спасателями
}

Опасные последствия страха в условиях ЧС:{

~ %25%появление беспокойства, тревоги, слабости

~ %25% нарушения адекватного функционирования нервной системы

~ %25% истерические реакции

~ %25% состояние безысходности, отказ от сопротивления

~ %-100%неприятные воспоминания о прошедших ситуациях
}

Какие мероприятия способствуют предупреждению панических реакций в ЧС:{

~ %25% обучение поведению в чрезвычайных ситуациях

~ %25% профессиональный психологический отбор руководителей, медицинских работников и спасателей, работающих в опасных условиях

~ %25% достоверное, достаточно полное информирование населения о случившемся

~ %25% своевременные действия волевых, ответственных людей

~ %-100%отсутствие опыта психопрофилактической работы у медицинских работников и спасателей
}

Каким образом возможно устранить паническую реакцию среди пострадавших в ЧС:{

~ %33.33333% своевременно изолировать паникеров

~ %33.33333%отдавать категорические приказы

~ %-100%привлечь спасателей, полицию для применения силовых методов

~ %33.33333%попытаться уменьшить группу присутствующих
}

В очаге ЧС можно ожидать развития следующих форм острого психического нарушения поведения:{

- ~ %33.33333% речедвигательное возбуждение
- ~ %33.33333% ступор
- ~ %33.33333% депрессия
- ~ %-100% обострение хронических заболеваний
- }

Задачи медико-психологической помощи в зоне чрезвычайной ситуации:

- ~ %33.33333% раннее выявление лиц с психическими расстройствами в очаге чрезвычайной ситуации
- ~ %-100% проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки
- ~ %33.33333% раннее выявление лиц с психическими расстройствами в местах сосредоточения эвакуированных из зоны чрезвычайной ситуации
- ~ %33.33333% осуществление доступных мер профилактики расстройств психического здоровья
- }

Выраженное воздействие на эмоциональную сферу пострадавших в ЧС происходит в результате:

- ~ %20% наблюдение за развитием динамики катастрофы
- ~ %20% социальных проблем, возникших после катастрофы
- ~ %20% материального ущерба
- ~ %20% снижения или утраты способности самостоятельно удовлетворять потребности в тепле, пище, безопасности
- ~ %20% гибели родственников и близких
- }

Характер психического реагирования населения на явления и процессы при ЧС зависят от:

- ~ %33.33333% готовности отдельных людей к деятельности в экстремальных (необычных) условиях
- ~ %-100% проведения эвакуации в безопасные районы
- ~ %33.33333% степени психологической устойчивости пораженных, медицинских работников и спасателей
- ~ %33.33333% волевой и физической закалки пораженных, спасателей и медицинских работников
- }

Факторы, влияющие на психологическое состояние пострадавших в ЧС, связанные с особенностями организации помощи:{

~ %25% **характер освещения в средствах массовой информации хода аварийно-спасательных работ**

~ %25% **особенности информационного обеспечения пострадавших в ЧС**

~ %-100%**погодные условия**

~ %25% **плохая организация аварийно-спасательных работ**

~ %25% **профессионально-грамотная организация аварийно-спасательных работ**

}

Климатогеографические факторы, определяющие психическое состояние и поведение спасателей:{

~ %33.33333%**смена часовых поясов**

~ %-100%**работа в зоне радиоактивного загрязнения**

~ %33.33333% **особенности рельефа местности**

~ %33.33333% **смена климатических поясов**

}

Психофизиологические факторы, определяющие психическое состояние и поведение спасателей:{

~ %-100%**неспособность своевременно изолировать паникеров**

~ %33.33333% **нарушение режима питания**

~ %33.33333% **отсутствие полноценного отдыха**

~ %33.33333% **многодневная интенсивная 16-18 часовая физическая нагрузка**

}

К объективным факторам, определяющим психическое состояние и поведение спасателей в ЧС, следует отнести:{

~ %33.33333% **климатогеографические**

~ %33.33333% **психогигиенические**

~ %-100%**настроение спасателей**

~ %33.33333% **психофизиологические**

}

Если у пострадавшего развилась истерика, следует:{

- ~ %50% говорить тихо, медленно и четко
 - ~ %50% лишить пострадавшего внимания окружающих
 - ~ %-50% совершить неожиданное отвлекающее действие (громко крикнуть, дать пощечину)
 - ~ %-50% говорить с пострадавшим напористо и громко, заставив выполнить конкретное поручение
- }

Если у пострадавшего развился ступор, следует: {

- ~ %50% говорить тихо, медленно и четко
 - ~ %50% совершить неожиданное отвлекающее действие (например, громко крикнуть)
 - ~ %-50% говорить с пострадавшим напористо и громко, заставив выполнить конкретное поручение
 - ~ %-50% лишить пострадавшего внимания окружающих
- }

Острые психические реакции у пострадавших могут проявляться в виде: {

- ~ %33.33333% истерики
 - ~ %33.33333% агрессивного поведения
 - ~ %33.33333% ступора
 - ~ %-100% галлюцинации
- }

Цель медико-психологической помощи в ЧС реализуется в рамках: {

- ~ %33.33333% профилактики острых панических реакций
 - ~ %33.33333% психопрофилактических и психогигиенических мероприятий
 - ~ %-100% формирования позитивного общения пострадавших со спасателями
 - ~ %33.33333% психотерапии возникших нервно-психических нарушений
- }

Первая медико-психологическая помощь в очаге ЧС направлена на предупреждение: {

- ~ %50% агрессивных форм поведения
- ~ %50% панических реакций

- ~ %-50% ипохондрических состояний
 - ~ %-50% обострения хронических заболеваний
- }

Если у пострадавшего развилось агрессивное поведение, следует: {

- ~ %20% не оставлять пострадавшего одного
 - ~ %20% свести к минимуму количество окружающих
 - ~ %20% дать пострадавшему возможность «выпустить пар»
 - ~ %20% поручить работу, связанную с высокой физической нагрузкой
 - ~ %20% демонстрировать доброжелательность
- }

Признаки развития агрессивного поведения у пострадавшего в ЧС: {

- ~ %25% раздражение, недовольство, гнев (по любому поводу)
 - ~ %25% нанесение окружающим ударов руками или другими предметами
 - ~ %25% словесное оскорбление, брань
 - ~ %25% мышечное напряжение
 - ~ %-100% проявление депрессивного состояния
- }

Во время жизнеопасных обстоятельств у пострадавших при ЧС наблюдаются: {

- ~ %-50% воспоминания о прожитой жизни
 - ~ %-50% формирование основных жизненных позиций, желание все начать сначала
 - ~ %50% острые психические нарушения поведения
 - ~ %50% состояния психической дезадаптации
- }

Признаки развития реакции страха у пострадавшего в ЧС: {

- ~ %25% напряжение мышц (особенно лицевых)
 - ~ %25% частое, сильное сердцебиение
 - ~ %-100% нанесение окружающим ударов руками или другими предметами
 - ~ %25% снижение контроля собственного поведения
 - ~ %25% учащенное поверхностное дыхание
- }

При работе с острыми стрессовыми реакциями у пострадавших в ЧС в первую очередь помощь оказывается при:{

- ~ %-50%ступоре**
 - ~ %-50%нервной дрожи**
 - ~ %50%психомоторном возбуждении**
 - ~ %50% истероидной реакции, агрессии**
- }**

Существенные различия в возникновении нервно-психических расстройств у населения в ЧС по сравнению с обычными условиями определяются тем, что:{

- ~ %33.33333% клиническая картина расстройств не носит строго индивидуальный характер, а сводится к небольшому числу достаточно типичных проявлений**
 - ~ %33.33333% одномоментное возникновение нервно-психических расстройств у большого числа пострадавших**
 - ~ %-100%стремительное развитие нервно-психических расстройств**
 - ~ %33.33333% несмотря на наличие нервно-психических расстройств и продолжающуюся опасную ситуацию, пострадавший человек вынужден продолжать активную борьбу за свою жизнь, жизнь близких и окружающих**
- }**

Если у пострадавшего развился плач, следует:{

- ~ %25%не оставлять пострадавшего одного**
 - ~ %25% установить с пострадавшим физический контакт (взять за руку, погладить по голове)**
 - ~ %-100%говорить с пострадавшим напористо и громко, заставив выполнить конкретное поручение**
 - ~ %25% применить приемы «активного слушания»**
 - ~ %25% не задавать вопросов, не давать советов**
- }**

Если у пострадавшего развилось речедвигательное возбуждение, следует:{

- ~ %25% не оставлять пострадавшего одного**
- ~ %25% уговорить пострадавшего от совершения опасных действий**
- ~ %25%если не удастся уговорить пострадавшего от совершения**

опасных действий, использовать способы удержания и фиксации

~ %-100%применить приемы «активного слушания»

~ %-25% при необходимости привлечь для удержания и фиксации окружающих лиц
}

Если у пострадавшего развились галлюцинация и бред следует:{

~ %-50% не оставлять пострадавшего одного

~ %-50% незамедлительно эвакуировать в медицинскую организацию с сопровождением (при необходимости использовать способы удержания и фиксации)

~ %-50%совершить неожиданное отвлекающее действие (например, громко крикнуть)

~ %-50%говорить с пострадавшим напористо и громко, заставив выполнить конкретное поручение
}

Понятие об экстремальности в условиях чрезвычайной ситуации{

~ ситуации, в которых человек не может принять правильное решение, отмечается не адекватное в данной обстановке поведение

~ обстановка, при которой возникает или может возникнуть паника человека или группы людей

~ ситуации, при которой возникает или может возникнуть истерики и галлюцинации

= воздействие на человека таких условий, при которых его психика действует на пределе, а также выше предела возможного для данной личности и после которых возникают изменения его индивидуально-психологических черт

}

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16.

Безопасность медицинского труда.

Безопасность медицинских услуг.

Инструктивные занятия (инструктажи) по обучению безопасным способам и приемам выполнения работ могут быть:{

- ~ %-100%заклучительными
- ~ %33.33333%вводными
- ~ %33.33333%первичными
- ~ %33.33333%повторными
- }

Вводный инструктаж должен проводиться: {

- ~ %20%лицам, принимаемым на временную работу
- ~ %20%студентам и стажерам, обучающимся в медицинской организации
- ~ %20%лицам, с высшим профессиональным образованием по специальности
- ~ %20%лицам, со стажем работы в такой же должности более 25 лет
- ~ %20%лицу, назначенному главным врачом больницы
- }

Работников, отказывающихся от прохождения обязательных периодических профилактических осмотров: {

- ~штрафуют
- ~подвергают аресту
- =не допускают к работе
- ~не пускают в очередной отпуск
- ~направляют на принудительное обследование
- }

При уколах и порезах во время медицинских манипуляций необходимо срочно: {

- ~обратиться к врачу
- ~снять перчатки, вымыть руки с мылом, выдавить из ранки кровь и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода
- ~снять перчатки, вымыть руки проточной водой с мылом, выдавить из ранки кровь и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода
- =не снимая перчаток, вымыть руки проточной водой с мылом, снять печати, выдавить из ранки кровь, вымыть руки с мылом и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода
- ~продолжать выполнять свои должностные обязанности
- }

При обслуживании пациентов врачу необходимо проявлять

постоянную бдительность в отношении:{

- ~ %25%радиационной опасности**
 - ~ %25%биологической опасности**
 - ~ %25%химической опасности**
 - ~ %-100%опасности вооруженного нападения**
 - ~ %25%проявлений неадекватных психических реакций пациента**
- }**

Стирку санитарно-гигиенической одежды медицинского персонала необходимо проводить:{

- ~индивидуально в специально выделенных помещениях лечебно-диагностических отделений**
 - =централизовано в прачечных отдельно от белья пациентов**
 - ~индивидуально в домашних условиях**
 - ~по усмотрению медицинских работников**
 - ~в строгом соответствии с указаниями руководителя медицинской организации**
- }**

При оказании медицинской помощи могут использоваться:{

- ~ %20%индивидуальные средства защиты кожи**
 - ~ %20%защитные очки и прозрачные щитки**
 - ~ %20%защитные маски**
 - ~ %20%противочумные костюмы**
 - ~ %20%респираторы**
- }**

Врачи и медицинские сестры при исполнении функциональных обязанностей обязаны мыть и дезинфицировать руки:{

- ~ %20%перед осмотром каждого пациента**
 - ~ %20%после осмотра каждого пациента**
 - ~ %20%после посещения туалета**
 - ~ %20%после манипуляций с предметами, имеющими биологическое загрязнение**
 - ~ %20%после посещения курительной комнаты**
- }**

Порядок хранения рабочей одежды медицинского персонала больницы:{

- ~ %50%требует наличия индивидуальных двухсекционных шкафов для хранения рабочей одежды отдельно от повседневной одежды
 - ~ %-50%определяет необходимость закрепления индивидуальных полок в шкафах для хранения рабочей одежды
 - ~ %50%рекомендует иметь комплект рабочей одежды для экстренной замены в случае загрязнения
 - ~ %-50%изменяется в зависимости от реальных возможностей данной медицинской организации
- }

Основными законодательными документами по охране труда являются: {

- ~ %33.33333%Конституция РФ
 - ~ %33.33333%Трудовой кодекс РФ
 - ~ %33.33333%Закон РФ «Об основах охраны труда» от 17 июля 1999г.
 - ~ %-100%Уголовно-процессуальный Кодекс
- }

Согласно Трудовому Кодексу РФ, запрещено применение на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда лиц моложе: {

- =18 лет
 - ~15 лет
 - ~20 лет
 - ~ 16 лет
- }

Различают следующие виды инструктажа по охране труда {

- ~ %25%вводный
 - ~ %25%первичный
 - ~ %25%повторный
 - ~ %25%внеплановый
 - ~ %-100%ежегодный
- }

Физические факторы, воздействующие на медицинский персонал: {

- = вибрация, шум
- ~ лекарственные препараты
- ~пломбировочные материалы
- ~ дезинфектанты

}

Химические факторы, воздействующие на медицинский персонал{

~ электромагнитное и ультрафиолетовое излучение

= антисептики

~ лекарственные препараты

~пломбировочные материалы

}

Структура заболеваний медперсонала: {

=инфекционная патология, аллергические заболевания, интоксикации и заболевания опорно-двигательного аппарата

~ аллергические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, патология пищеварительного тракта

~ инфекционная патология, неврологические заболевания, интоксикации

~серечно-сосудистые заболевания, патология опорно-двигательного тракта

}

Безопасная больничная среда – это:{

=идеально сформированная больничная среда, не причиняющая вреда всем участникам лечебного процесса

~ больничная среда, в которой идеально соблюдается техника безопасности

~ больничная среда с высоким уровнем высокотехнологичных медицинских устройств

~ больничная среда, не причиняющая вреда всем участникам жизнедеятельности

}

Для создания безопасной больничной среды необходимо:

{

~ увеличить долю неквалифицированного труда

=обеспечивать эффективный контроль за действием вредных производственных факторов на рабочих местах

~ исключать обучение вопросам профессиональной безопасности, психогигиены, методик релаксации

~ отмена профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья

граждан

}

Создание работникам медицинского учреждения здоровых и безопасных условий труда обязан организовать:{

=главный врач и его заместители

~ заведующий отделением

~ старшие медицинские сестры

~ заведующий отделением

}

Медицинская помощь надлежащего качества (качественная медицинская помощь) это:

{

~ любое медицинское вмешательство с целью диагностики, лечения или иной целью, имеющей профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность, выполняемое врачом либо другим медицинским работником

~ действие (бездействие) медицинского персонала, при котором помощь (услуга) не соответствует обязательным требованиям, предусмотренным законом или условиям договора

=медицинская помощь, оказываемая медицинским работником, исключая негативные последствия, затрудняющие стабилизацию или увеличивающие риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск возникновения нового патологического процесса

~ любое медицинское вмешательство, имеющей профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность, выполняемое врачом

}

К основным принципам охраны здоровья граждан в Российской Федерации относятся:{

~ отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека

=соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий и доступность медицинской помощи

~ отмена профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья граждан

~ в интересах обследования и лечения пациента
}

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:{

= при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений

~ для проведения научных исследований, издания публикаций в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе

~ в интересах обследования и лечения пациента

**~ отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека
}**

Основными принципами охраны здоровья граждан в Российской Федерации являются:{

~ отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека

=соблюдение врачебной тайны

~ разрешение эвтаназии

~ принцип организации труда

}

Причинами вспышек внутрибольничных инфекций являются:{

~ соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

= перебои с подачей горячей и холодной воды, проведение ремонтных работ без закрытия стационарных отделений

~ изоляция заболевших и проведения противоэпидемических мероприятий

~ правильный выбор тактики лечения

}

Основными рисками ошибок в процессе лечения являются:{

= недостаточный уровень знаний в области клинического прогнозирования

~ квалифицированный анализ и оценка эффективности разных технологий лечения

~ правильный выбор тактики лечения

~ соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

}

В медицинских организациях острые отравления чаще всего происходят из- за:{

~ неосторожного применения сильнодействующих лекарственных препаратов и химических веществ в процессе выполнения медицинских процедур

~ нарушения правил проведения химической стерилизации и дезинфекции

=нарушений санитарно-гигиенических норм в работе объектов питания (пищевые отравления) и водоснабжения

~ соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

}

В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников преобладают:{

~ инфекционные заболевания

= аллергические заболевания интоксикации и заболевания опорно-двигательного аппарата

~нервно-психические заболевания

~ заболевания пищеварительного тракта

}

В условиях эпидемического неблагополучия медицинские работники должны:{

=подвергаться иммунопрофилактике (иммунизации)

~ подвергаться неспецифической профилактике(применение антибиотиков)

~ подвергаться санитарной обработке

~ подвергать специальной обработке

}

Вводный инструктаж должен проводиться:{

=лицам, принимаемым на временную работу, лицам, принимаемым на постоянную работу

~ в случае выявления нарушений работниками требований безопасности труда

~ непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своей трудовой деятельности

~ непосредственно на рабочем месте в соответствии с календарным планом

}

Внутрибольничными инфекциями называют...{

= если они впервые проявляется через 48 часов или более после нахождения в больнице, при условии отсутствия клинических проявлений этих инфекций в момент поступления и исключения вероятности инкубационного периода

~ действие медицинского персонала, при котором помощь не соответствует обязательным требованиям, предусмотренным законом или условиям договора

~которые проявляются после выписывания больного из больницы

~нарушение санитарно-гигиенического режима и проблемы стерилизации

}

Главным требованием к системе здравоохранения в сфере безопасности медицинских услуг является:{

= предоставление качественной медицинской помощи

~действия по созданию и поддержанию особых режимов функционирования подразделений и запретных зон

~ санитарно-топографические, архитектурно-планировочные, инженерные

~ систематическая рационализация штатного расписания, прием на работу и подготовка работников

}

К мерам по охране здоровья направленных на обеспечение безопасности медицинских услуг относятся:{

~ %25% санитарно-топографические, архитектурно-планировочные, инженерные и санитарно-технические мероприятия

~ %25%правильная эксплуатация и своевременное техническое обслуживание зданий, сооружений, технологического оборудования и медицинской техники

~ %25%действия по созданию и поддержанию особых режимов функционирования подразделений и запретных зон

~ %25%систематическая рационализация штатного расписания, прием на работу и подготовка работников с учетом обеспечения безопасности пациентов

}

Конфликтные ситуации в медицинских организациях могут возникать в следствие:{

- ~ %25%совместного размещения пациентов из разных социальных и имущественных слоев общества**
 - ~ %25%отсутствия со стороны медицинских работников воспитательного воздействия на пациентов с низким уровнем культуры**
 - ~ %25%эмоционального перенапряжения медицинских работников**
 - ~ %25%отсутствие элементарной культуры персонала**
 - ~ %-100%неудовлетворительная организация лечебно-диагностического процесса и бытового обслуживания пациентов**
- }**

Медицинские работники при выполнении медицинских вмешательств обязаны применять:{

- ~ %50%одноразовые стерильные инструменты и материалы**
 - ~ %50%многократные инструменты и материалы, прошедшие стерилизацию установленным для них способом**
 - ~ %-50%многократные инструменты и материалы**
 - ~ %-50%одноразовые инструменты и материалы**
- }**

Общие обязанности работников, в том числе медицинских, по охране труда и технике безопасности установлены:{

- ~ %50% Федеральным законом РФ от 30.12.2001 п 197-ФЗ**
 - ~ %50% «Трудовой Кодекс Российской Федерации»**
 - ~ %-50% Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»**
 - ~ %-50%Конституция Российской Федерации**
- }**

Окружающей средой медицинского труда являются:{

- =производственная, медицинская, внутрибольничная среда**
 - ~ производственная и внутрибольничная среда**
 - ~ внутрибольничная среда**
 - ~ медицинская и производственная среда**
- }**

Основной предпосылкой возгораний в операционных помещениях

является...{

**= использование в современной хирургической практике
огнеопасных жидкостей, газов и электрических устройств**

~ неудовлетворительное устройство рабочих помещений

~ несовершенство технологических процессов

~ не соблюдение правил пожарной безопасности

}

**Основу нормативной правовой базы системы управления охраной
труда в медицинских организациях составляют:{**

~ %33.33333% Конституция Российской Федерации

**~ %33.33333% Федеральный Закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»**

~ %33.33333% Трудовой Кодекс № 197-ФЗ от 30.12.2001 г.

**~ %-100% Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения»**

}

**При попадании биологической жидкости пациента в глаза
медицинского работника, ему необходимо немедленно:{**

~ промыть глаза проточной водой

= промыть глаза водным раствором калия перманганата 1:10000

~ вызвать скорую медицинскую помощь

~ промыть глаза мыльным раствором

}

**При попадании биологической жидкости пациента на слизистые
оболочки ротоглотки медицинского работника, ему необходимо ...{**

**= немедленно прополоскать 70% раствором этилового спирта или
0,05% раствором марганцево-кислого калия**

~ вызвать скорую медицинскую помощь

~ обработать кожным антисептиком

~ прополоскать мыльным раствором

}

**При проведении лабораторных и инструментальных исследований
компонентов вредных и опасных факторов окружающей среды
используют комплекс методов...{**

~ %25% физических

- ~ %25% химических
 - ~ %25%биологических
 - ~ %25%органолептических
- }

Без периодических медицинских осмотров:{

=не допускают к работе

~штрафуют

~подвергают аресту

~не пускают в очередной отпуск

~направляют на принудительное обследование

}

Проблема чистых рук медицинских работников решается посредством...{

~ %50%применения одноразовых стерильных перчаток

~ %50%выполнения правил личной гигиены и текущей обработки перчаток антисептическими растворами

~ %-50%дезинсекции

~ %-50%дезинфекции

}

Система охраны труда в медицинских организациях обязывает работников:{

~ %25%правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты

~ %25%проходить обучение безопасным способам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи

~ %-100%организация оперативных мероприятий по обеспечению порядка и ликвидации последствий ЧС

~ %25%немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или ухудшении состояния своего здоровья

~ %25%проходить обязательные предварительные, периодические и внеочередные медицинские осмотры

}

Среди врачей различных специальностей особенно подвержены стрессам...{

= реаниматологи и хирурги
~ стоматологи-хирурги
~ терапевты и ортопеды
~ реаниматологи и терапевты
}

Требования по безопасности к поведению медицинских работников заключаются...{

~ %50%в знании и строгом выполнении правил техники безопасности при работе с технологическим оборудованием и лекарственными средствами

~ %50%в проявлении постоянной бдительности в отношении радиационной, химической и биологической опасности при обслуживании пациентов

~ %-50%высокой работоспособности врача в течение рабочего времени

~ %-50%отсутствие или несовершенство средств индивидуальной защиты

}

Факторами риска возникновения профессиональной патологии у медицинских работников являются:{

~ %-100%острые респираторные заболевания

~ %25%неудовлетворительное устройство рабочих помещений

~ %25%несовершенство оборудования и инструментария

~ %25%несовершенство технологических процессов

~ %25% отсутствие или несовершенство средств индивидуальной защиты

}

Факторами риска профессиональной патологии у медицинских работников являются...{

~ %25%неудовлетворительное устройство рабочих помещений

~ %25%несовершенство оборудования и инструментария

~ %25%длительный контакт с лекарственными средствами и вредными веществами

~ %25%отсутствие или несовершенство средств индивидуальной защиты

~ %-100%отсутствие средств коллективной защиты

}

Чаще всего профессиональные заболевания медицинских работников регистрируются у: {

~врачей, санитарок

~ руководителей медицинских организаций

= врачей, медсестер, санитарок

~глав.врачей и санитарок

}

Чрезвычайная ситуация в медицинской организации возникает вследствие... {

~ %50%значительного несоответствия имеющихся медицинских сил и средств и потребности пострадавших в медицинской помощи

~ %50% одномоментного поступления большого количества пострадавших

~ %-50%резкого ухудшения условий жизнедеятельности медицинских работников и пациентов

~ %-50%длительный контакт с лекарственными средствами и вредными веществами

}

В целях обеспечения безопасности медицинских услуг медицинские работники должны... {

~уметь применять способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности пациентов

~осуществлять мероприятия по защите пациентов в чрезвычайных ситуациях

~ владеть приёмами и способами эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях

= обеспечить качество медицинских вмешательств

}

В целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний работники медицинских организаций обязаны проходить...{

~ %50%обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры (обследования),

~ %50%периодические медицинские осмотры (обследования)

- ~ %-50%внеплановые медицинские осмотры
- ~ %-50% медицинские осмотры
- }

Медицинский труд представляет собой...{

= совокупность факторов трудового процесса и окружающей среды (производственной, медицинской, госпитальной, больничной, внутрибольничной)

~ действие медицинского персонала, при котором помощь не соответствует обязательным требованиям, предусмотренным законом или условиям договора

~ комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

~ комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний

}

Во время своей профессиональной деятельности медицинские работники подвергаются:{

= воздействию факторов физической, химической, биологической и психофизиологической природы

~ воздействию факторов биологической и психофизиологической природы

~ воздействию факторов физической, химической, биологической природы

~ воздействию факторов биологической, физической, химической природы

}

К профессиональным ошибкам медицинских работников относятся:{

~ %50% диагностические/ лечебно-тактические и лечебно-технические

~ %50% деонтологические и организационные

~ %-50%технические

~ %-50%управленческие и организационные

}

К психофизиологическим факторам, воздействующим на

медицинских работников в процессе их труда, относятся:{

- ~ %25%статические и динамические перегрузки**
 - ~ %25% перенапряжение анализаторов**
 - ~ %25% монотонность труда**
 - ~ %25%эмоциональные перегрузки**
- }**

К факторам биологической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся:{

= вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций

- ~гельминты**
 - ~клещи и насекомые**
 - ~грызуны и другие животные**
- }**

К факторам физической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся...{

~ %25%рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

~ %25% повышенная или пониженная температура поверхностей и воздуха

- ~ %-100%ядовитые продукты горения**
 - ~ %25% высокие уровни напряжения в электрической цепи**
 - ~ %25% резкие перепады барометрического давления**
- }**

К факторам химической природы, воздействующим на медицинских работников в процессе их труда, относятся...{

~ %50% пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций

- ~ %50%продукты горения и отсутствие кислорода при возгораниях**
 - ~ %-50%резкие перепады барометрического давления**
 - ~ %-50%контакт с инфекционными больными**
- }**

Медицинская деятельность — это...{

=профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи,

проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией органов и тканей, обращением донорской крови и ее компонентов в медицинских целях

~ исследование влияния различных факторов среды на здоровье населения, осуществляемое научными гигиеническими и эпидемиологическими учреждениями; гигиеническое нормирование факторов среды обитания человека, предупреждающее неблагоприятное воздействие их на здоровье населения

~ совокупность факторов трудового процесса и окружающей среды (производственной, медицинской, госпитальной, больничной, внутрибольничной)

~ выполняемые медицинской организацией по отношению к пациенту, затрагивающие физическое состояние человека и имеющие профилактическую, лечебную направленность виды медицинских обследований и медицинских манипуляций.

}

Медицинское вмешательство – это...{

=выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций;

~ совокупность факторов трудового процесса и окружающей среды (производственной, медицинской, госпитальной, больничной, внутрибольничной);

~ выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое состояние человека и имеющие профилактическую, лечебную направленность виды медицинских обследований и медицинских манипуляций;

~ выполняемые медицинской организацией по отношению к пациенту, затрагивающие физическое состояние человека и имеющие профилактическую, лечебную направленность виды медицинских обследований и медицинских манипуляций.

}

Опасными и вредными биологическими факторами медицинской

среды являются...{

- ~ %33.33333% болезнетворные вирусы и микроорганизмы**
 - ~ %33.33333%гельминты**
 - ~ %33.33333%клещи и насекомые**
 - ~ %-100%грызуны и другие животные**
- }**

Опасными и вредными психофизиологическими факторами медицинской среды являются...{

- ~ %50%травмирующие операции**
 - ~ %50% гиподинамия и нервно-психические, психоэмоциональные перегрузки**
 - ~ %-50%пренебрежительное отношение посторонних лиц**
 - ~ %-50% использование агрессивных жидкостей**
- }**

Опасными и вредными физическими факторами медицинской среды являются:{

- ~ %20% механические**
 - ~ %20%термические**
 - ~ %20%радиационные**
 - ~ %20%электрические**
 - ~ %20%барометрические**
- }**

Опасными и вредными химическими факторами медицинской среды являются...{

- ~ %25%химические вещества (в том числе лекарственные средства), способные вызвать острое или хроническое отравления**
 - ~ %25%дезинфицирующие средства**
 - ~ %25% антибиотики**
 - ~ %25% средства для ингаляционного наркоза**
 - ~ %-100%патогенные вирусы и микроорганизмы**
- }**

Система охраны труда медицинской организации представляет собой...{

= сформированную руководителем совокупность должностных лиц и организационных связей, предназначенных для управления

деятельностью по сохранению жизни и здоровья работников в процессе труда

~ **организацию обучения приемам диагностики и оказания неотложной медицинской помощи**

~ **соблюдение требований охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты**

~ **аттестация рабочих мест по условиям труда, система анализа и оценки профессиональных знаний и навыков работающего на конкретном рабочем месте, его соответствие занимаемой должности**

}

Во время оказания медицинских услуг пациенты могут подвергаться воздействию:{

~ **%50%вредных и опасных факторов внешней среды**

~ **%-50%физических, химических и биологических факторов**

~ **%-50%химических и психофизиологических факторов**

~ **%50%комбинации физических, химических, биологических и психофизиологических факторов**

}

Неадекватные психические реакции пациентов и персонала могут привести к:{

~ **%50%излишнему эмоциональному напряжению**

~ **%50%механической травме**

~ **%-50%выздоровлению пациента с болезнями сердца, сосудистой и нервной систем**

~ **%-50%созданию конфликтных ситуаций**

}

Лучевые поражения пациента могут возникнуть при:{

~ **%-50%однократном рентгенологическом исследовании**

~ **%-50%двукратном рентгенологическом исследовании**

~ **%50%многократном рентгенологическом исследовании**

~ **%50%нарушении правил радиационной безопасности**

}

Пожар и возгорания в медицинской организации опасны для пациентов тем, что вызывают:{

~ **%33.33333%ожоги кожи и слизистых оболочек дыхательных путей**

- ~ %33.33333%отравление токсичными продуктами горения
 - ~ %-100%обострение хронических болезней костей и суставов
 - ~ %33.33333%панику среди пациентов
- }

Конфликтные ситуации в медицинских организациях возникают в следствие:{

- ~ %33.33333%совместного размещения пациентов из разных социальных и имущественных слоев общества
 - ~ %33.33333%отсутствия со стороны медицинского персонала воспитательного воздействия на лиц с низким уровнем культуры
 - ~ %-100% необходимости обслуживания пациентов с психическими расстройствами
 - ~ %33.33333%эмоционального перенапряжения медицинских работников
- }

Падения людей в старческом возрасте – это:{

- ~крайне редкое и естественное явление, не требующее особой подготовки медицинского персонала
 - ~чрезвычайно опасное для жизни состояние, требующее постоянного постельного режима
 - =эпизодическое проявление расстройства организма, требующее от врача умения оценивать риск падения и готовности организовать комплекс мероприятий по предупреждению травм и оказанию первой помощи
 - ~проблема службы оказания социальной помощи инвалидам и лицам старческого возраста
- }

Обезболивание при медицинских манипуляциях опасно тем, что:{

- ~развивается привыкание и наркотическая зависимость к анестетикам
 - =имеется возможность возникновения анафилактического шока со смертельным исходом
 - ~возможно отсутствие обезболивающего эффекта
 - ~наступает опьянение пациента
 - ~возможно инфицирование пациента
- }

Основными направлениями функционирования системы охраны труда медицинской организации, как правило, являются:{

~ %33.33333%обучение и профессиональная подготовка работников в области охраны труда

~ %33.33333%предупреждение несчастных случаев и нарушения здоровья работников

~ %33.33333%контроль соблюдения нормативных требований охраны труда

~ %-100%привлечение к административной и уголовной ответственности нарушителей требований охраны труда

}

Медицинская помощь надлежащего качества (качественная медицинская помощь) это:

{

~ любое медицинское вмешательство с целью диагностики, лечения или иной целью, имеющей профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность, выполняемое врачом либо другим медицинским работником

~ действие (бездействие) медицинского персонала, при котором помощь (услуга) не соответствует обязательным требованиям, предусмотренным законом или условиями договора

=медицинская помощь, оказываемая медицинским работником, исключая негативные последствия, затрудняющие стабилизацию или увеличивающие риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск возникновения нового патологического процесса

~ любое медицинское вмешательство имеющей профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность, выполняемое врачом либо другим медицинским работником

}

К основным принципам охраны здоровья граждан в Российской Федерации относятся:{

~ отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека

=соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий и доступность медицинской помощи

~ отмена профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья граждан

~ в интересах обследования и лечения пациента

}

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:{

= при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений

~ для проведения научных исследований, издания публикаций в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе

~ в интересах обследования и лечения пациента

~ отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека

}

Основными принципами охраны здоровья граждан в Российской Федерации являются:{

~ отказ в оказании медицинской помощи при угрозе жизни человека

= соблюдение врачебной тайны

~ разрешение эвтаназии

~ санитарные нормы

}

Причинами вспышек внутрибольничных инфекций являются:{

~ соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

= перебои с подачей горячей и холодной воды, проведение ремонтных работ без закрытия стационарных отделений

~ изоляция заболевших и проведения противоэпидемических мероприятий

~ правильный выбор тактики лечения

}

Основными рисками ошибок в процессе лечения являются:{

= недостаточный уровень знаний в области клинического прогнозирования

~ квалифицированный анализ и оценка эффективности разных технологий лечения

~ правильный выбор тактики лечения

~ соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

}

Безопасность медицинских услуг направлена на...{

= обеспечение безопасности пациентов, медицинских работников и посетителей

~ коррекцию среды обитания и организма человека

~ повышение сопротивляемости организма воздействию внешних факторов

~ соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

}

Лучевые поражения пациента могут возникнуть при: {

= пренебрежительном отношении медицинских работников к учету дозовой нагрузки при рентгенологических исследованиях и лучевой терапии;

~ двукратном рентгенологическом исследовании;

~ нарушениях правил радиационной безопасности при строительстве, реконструкции и оборудовании рентгенологических и других радиоактивно опасных объектов.

~ длительный контакт с лекарственными средствами

}

На обеспечение безопасной фармакотерапии пациента направлены:{

~ %-100%опрос пациента о наличии у него аллергических реакций на лекарственные препараты

~ %33.33333%маркировка лекарственных препаратов

~ %33.33333% учет назначений лекарственных препаратов в медицинской карте

~ %33.33333%изучение показаний и противопоказаний лекарственных средств

}

Наиболее уязвимыми местами медицинских услуг (с точки зрения безопасности) являются:{

~ %33.33333%побочное действие лекарственных средств и их сочетаний

~ %33.33333%некачественная медицинская и фармацевтическая продукция

~ %33.33333%человеческий фактор

~ %-100% адекватная анестезия
}

Наиболее часто угрозы безопасности пациентов реализуются в форме...{

~ %33.33333% внутрибольничных инфекций
~ %33.33333% + профессиональных ошибок медицинских работников
~ %33.33333% неадекватных психических реакций пациентов и обслуживающего персонала
~ %-100% повышенных требований безопасности
}

Обеспечению безопасности пациентов препятствуют ряд проблем:{

~ %33.33333% падения пациентов
~ %-100% проблема службы оказания социальной помощи инвалидам и лицам старческого возраста
~ %33.33333% вероятность возникновения аллергической реакции на введение нового лекарственного средства
~ %33.33333% профессиональные ошибки медицинских работников
}

Определение термина «медицинская услуга» приведено в:{

~ %33.33333% нормативно - правовом акте Федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
~ %33.33333% в Конституции РФ
~ %33.33333% в Трудовом Кодексе
~ %-100% в федеральном законе «О безопасности»
}

Пожар и возгорания в медицинской организации опасны для пациентов тем, что:{

~ %33.33333% вызывают ожоги кожи и слизистых оболочек дыхательных путей
~ %-100% заболевания опорно-двигательного аппарата
~ %33.33333% нехватку кислорода (асфиксию)
~ %33.33333% панику среди пациентов
}

Потенциальными угрозами безопасности пациентов при оказании

медицинских услуг могут стать:{

- ~ %33.33333%сбои в работе системы жизнеобеспечения медицинских организаций (питания, водо- и электроснабжения, отопления, вентиляции)**
 - ~ %33.33333%внутрибольничный транспорт (лифты, тележки, каталки)**
 - ~ %33.33333% медицинская техника**
 - ~ %-100%неудовлетворительная организация лечебно-диагностического процесса.**
- }**

Предупреждение опасных электрических воздействий на пациента при оказании медицинских услуг достигается...{

- ~ %50%поддержанием медицинской электрической аппаратуры в исправном состоянии**
 - ~ %50%наличием медицинских работников, имеющих доступ к работе с электрооборудованием и аттестованных на квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй**
 - ~ %-50%наличием инженерно-технических средств**
 - ~ %-50%длительный контакт с лекарственными средствами**
- }**

У пациентов опасные последствия фармакотерапии могут возникать при...{

- ~ %33.33333%передозировке лекарственных препаратов**
 - ~ %33.33333%необоснованном применении лекарственных препаратов**
 - ~ %33.33333%при неосторожном применении сильнодействующих веществ**
 - ~ %-100%при нарушениях в работе объектов питания**
- }**

Установка камер видеонаблюдения в операционных, процедурных и других медицинских кабинетах необходима для...{

- ~ %-50%сбора компромата на неугодных сотрудников;**
- ~ %50% контроля за правильностью лечения;**
- ~ %50% достижения высокого доверия к врачу у крайне недоверчивых пациентов.**
- ~ %-50%при неосторожном применении сильнодействующих веществ**

}

Внутрибольничными инфекциями называют:{

~все случаи инфекционных заболеваний, выявленные в медицинской организации

~только те возбудители инфекционных болезней, которые обнаружены в помещениях больницы

=инфекционные заболевания людей, возникшие в результате их заражения в медицинской организации

~возбудители инфекционных болезней, выявленные при обследовании пациентов больницы

~инфекционные болезни, подтвержденные исследованиями, выполненными в больничной клинικο-диагностической лаборатории

}

На обеспечение биологической безопасности пациента направлены:{

~ %25%стерилизация инструментов

~ %25%санитарно-противоэпидемический режим медицинской организации

~ %25%текущая и генеральная уборка помещений

~ %25%профилактические осмотры медицинского персонала

}

На обеспечение химической безопасности пациента направлены:{

~ %25%опрос пациента о наличии у него аллергических реакций на лекарственные препараты

~ %25%маркировка лекарственных препаратов

~ %25%учет назначений лекарственных препаратов в медицинской карте

~ %25%изучение показаний и противопоказаний лекарственных средств

~ %-100%вакцинация пациента

}

Безопасность пациента — это... {

= предотвращение неблагоприятных исходов или повреждений во время процесса лечения или уменьшение ущерба в случае их наступления, обеспечение качества медицинских вмешательств

~ система мер медицинского характера, осуществляемых органами

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в целях профилактики заболеваний

~ состояние физического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма

~ комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению врача, целью которых является устранение заболевания пациента

}

Медицинская услуга — это:{

= медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение

~квалифицированный анализ и оценка эффективности разных технологий лечения

~ изоляция заболевших и проведение противоэпидемических мероприятий

~ комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний

}